

KC桌面——外资精译

世界银行：刚果金农村水卫项目改善了设施，却未能减少儿童腹泻

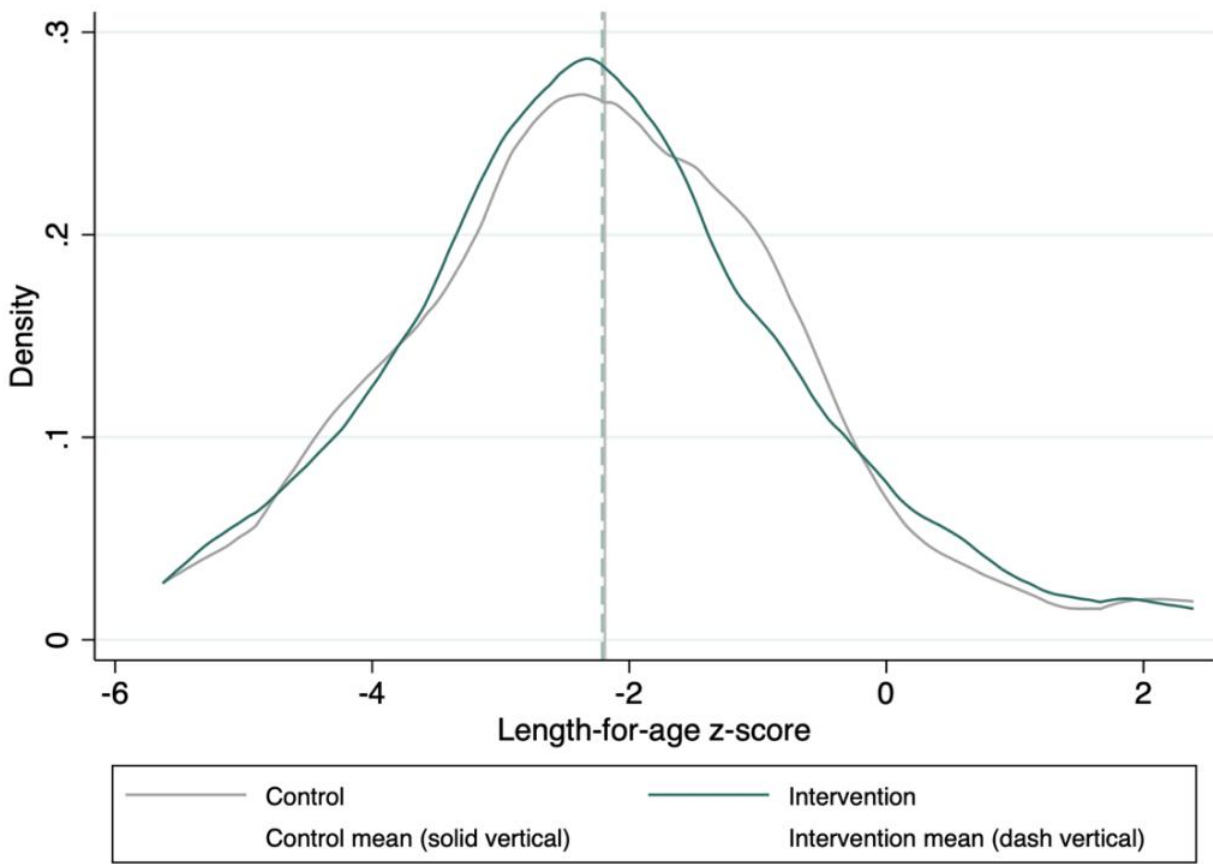
世界银行最新发布的一项随机对照试验评估了刚果民主共和国（DRC）全国性农村水、环境卫生与个人卫生（WASH）项目的实际效果。这项研究覆盖四个省份、121个村庄集群，在干预实施后平均3.6年进行追踪调查，结果令人深思：项目显著改善了基础设施和制度建设，但儿童腹泻率和生长发育迟缓并未得到改善。

基础设施和制度建设成效显著，但健康改善链条断裂

研究发现，干预组村庄在WASH机构指数上比对照组高出0.40个标准差。具体来看，干预组村庄拥有活跃的WASH委员会的比例比对照组高出21个百分点。家庭层面，干预组使用改善水源的可能性高出24个百分点，使用改善卫生设施的可能性高出18个百分点。这些改善在项目结束三年多后仍然持续存在。

然而，这些基础设施和制度建设的改善并未转化为儿童健康指标的提升。研究显示，干预对5岁以下儿童过去7天内的腹泻患病率没有显著影响，对儿童年龄别身高Z评分（衡量生长发育的指标）也没有显著影响。这意味着，尽管社区有了更好的水井和厕所，但儿童仍然同样容易腹泻，身高发育也没有改善。

> KC评论：这提醒我们，基础设施建设和健康改善之间并非简单的因果关系。有了水井不等于水就安全，有了厕所不等于所有人都正确使用。公共卫生干预的最后一公里往往是最难突破的。



图表 1

行为改变滞后：设施改善不等于行为改变

研究进一步揭示了基础设施改善与健康结果之间的脱节原因。尽管干预组家庭报告使用改善水源和卫生设施的比例显著提高，但实际水质检测结果并不理想。研究团队对水源点和家庭储水容器进行了大肠杆菌检测，发现

水质改善并未达到预期水平。

此外，干预组在洗手行为、卫生知识等行为改变指标上的改善有限。项目设定的“健康村”标准包括：至少60%的人口在饭前便后洗手、至少70%的人口了解粪口传播疾病知识等。但研究显示，这些行为改变目标并未充分实现。

值得注意的是，干预组对水治理的感知评价更为积极，包括对水管理机构的公平性、资金管理、故障响应等方面的满意度更高。这表明社区参与式方法在增强居民对公共服务的信任方面是有效的，但这种信任并未转化为健康行为的实质性改变。

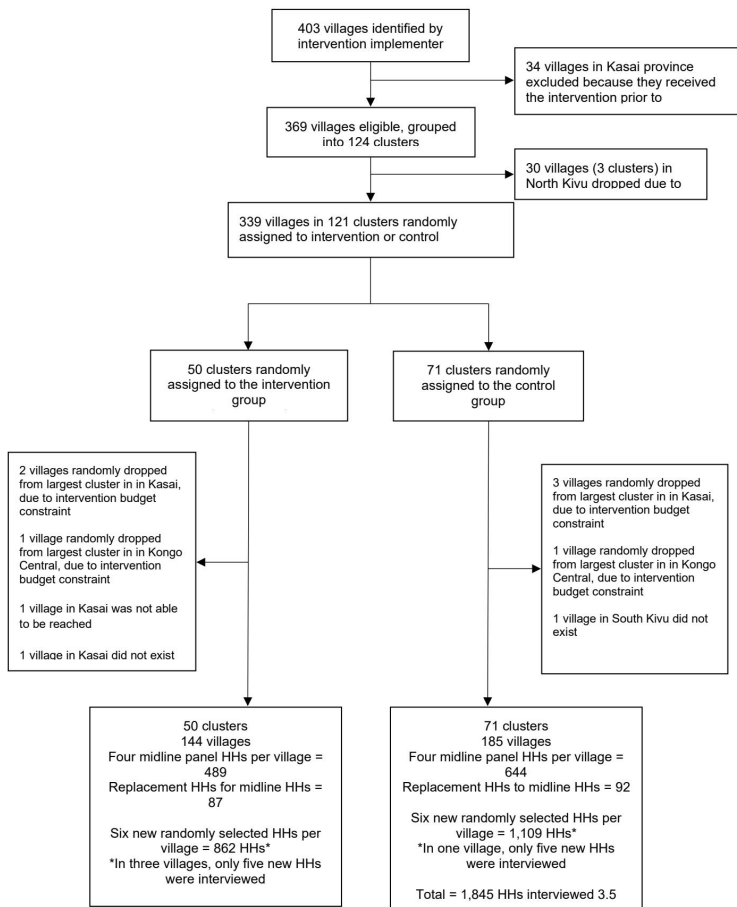
> KC评论：这给政策制定者的启示是：修水井、建厕所只是第一步，真正改变人们日常的卫生习惯才是关键。如果居民仍然不洗手、不妥善处理饮用水，再好的基础设施也难以降低腹泻率。

冲突环境下的长期评估：政策启示与挑战

这项研究是在刚果金这一冲突频发的背景下进行的，具有特殊价值。研究团队指出，全球约有六分之一的人口生活在武装冲突地区或附近，这些地区的WASH服务提供面临更大挑战。刚果金作为非洲面积第二大的国家，截至2020年仍有4800万人缺乏基本饮用水服务、1100万人露天排便、7200万人缺乏基本卫生服务。

研究采用了集群随机对照试验设计，在五个省份（刚果中部、开赛、中开赛、北基伍、南基伍）的121个村庄集群中随机分配干预组（50个集群）和对照组（71个集群）。最终在3.6年随访时调查了3283户家庭，随访率高达86%。

研究的核心发现对全球WASH政策具有重要启示：社区主导的WASH项目可以成功建设基础设施和制度，但這些改善本身并不足以自动带来健康收益。世界银行的研究团队指出，这是首个将新机构创建、基础设施资金和行为改变运动三者结合的随机试验，其长期随访（3.6年）为政策制定者提供了关于可持续性的现实评估。



图表 2

研究建议，未来的WASH干预需要更加强调行为改变的科学设计，确保基础设施改善能够真正转化为健康结果。同时，在冲突环境中实施此类项目时，需要考虑到安全局势对社区集体行动能力的影响。对于刚果金这样的

国家，要实现2030年可持续发展目标中的WASH相关目标，目前的进展速度需要加快3到6倍。